

Hasta Durum ve Gidişat Raporu

Klinik Takip Uygulaması — Kapsamlı Klinik Analiz

Ad Soyad Alaattin Sönmez **Cinsiyet** Erkek

Doğum Tarihi 1 Ocak 1962 (64 **Doğum Yeri** HATAY yaşında)

İkamet DEFNE / HATAY **Sigorta** SSK

Boy 174 cm **T.C. Kimlik gizlenmiştir** No

Ana Tanı Tip A Aort **Cerrahi** Bentall Prosedürü Diseksiyonu (20 Şub 2026)

Protez 25mm Carbomedics **Veri Aralığı** 19 Şub – 9 Eyl mekanik kapak + 2026 (~6,6 ay) 32mm Dacron greft

Güncel Durum Özeti (10 Eylül 2026)

Parametre Değer Not

Son Tansiyon (Eylül 111/76 mmHg (Son 7G: Hedef: <120/80 mmHg ort.) 111/75)

Güncel Kilo 78.4 kg 10 Eylül tartımı

Son INR 2.12 (10 Eyl) Hedef: 2,0–3,0 (mekanik kapak)

Son Hemoglobin 9.7 g/dL Referans: 13.5000–17.5000 (DÜŞÜK)

Son CRP 11.3 mg/L Referans: 0–5.0000 (YÜKSEK, zirve 154)

Toplam Tansiyon Ölçümü 490 7 aylık ev takibi

Şiddetli HT Atağı 5 Sistolik ≥ 150 / Diyastolik ≥ 100

Yatış Sayısı 3 Bentall + 2× postop komplikasyon

1. Yönetici Özeti

Sistem Tarafından Üretilen Klinik Değerlendirme

KLİNİK DEĞERLENDİRME RAPORU (19.02.2026 - 10.09.2026)

1. TANSİYON TRENDİ:

19.02.2026 - 10.09.2026 tarihleri arasında toplam 490 adet tansiyon ölçümü yapılmıştır. Dönem ortalaması 121/81 mmHg (Son 7 Gün: 111/75 mmHg) olarak hesaplanmıştır.

2. KİLO VE SIVI DURUMU:

Seçilen dönem sonu itibarıyla güncel kilo 78.4 kg'dır (Stabil, ödem negatif, dönem değişimi: -0.7 kg).

3. LABORATUVAR ANALİZLERİ:

10.09.2026 tarihi kontrol tahlillerine göre kritik parametre durumları şu şekildedir: INR: 2.12 (10 Eyl, Hedefte), PT: 19.8 sn, aPTT: 44.8 sn, PT%: %41.7, HGB: 9.7 (Düşük), WBC: 7.97 (Normal), CRP: 11.3 (Gerilemede). Bu dönemde referans aralığı dışında kalan parametreler: CHOL (Yüksek), CRP (Yüksek), FERRITIN (Düşük), HCT (Düşük), HDL (Düşük), HGB (Düşük), IRON (Düşük), LDL (Yüksek), MCH (Düşük), MCV (Düşük), RBC (Düşük), RDW-CV (Yüksek), RDW-SD (Yüksek).

4. İLAÇ TEDAVİSİ:

Klamoks 1000 mg kürü 10 Eylül 20:59'da tamamlandı ve kesildi. 10 Eylül'de reçetelenen Ferro Sanol Duodenal 100 mg sabah aç karnına (Panto'dan 1 saat önce) 11 Eylül 06:00'da başladı.

64 yaşındaki erkek hasta, 19 Şubat 2026 tarihinde ani başlayan yırtıcı karakterde göğüs ve sırt ağrısı ile acil servise başvurmuş; aynı gün içinde üç farklı merkeze sevk zinciriyle Tip A Aort Diseksiyonu ve 5,3 cm'lik asendan aort anevrizması + ciddi aort kapak yetmezliği tanısı kesinleştirilerek, tanıdan yaklaşık 10 saat sonra acil Bentall prosedürü (aort kökü + kapak + koroner buton replantasyonu) ile

ameliyat edilmiştir. Ameliyat başarılı geçmiş ve hasta 10 gün sonra şifa ile taburcu edilmiştir.

Ameliyat sonrası 6,6 aylık izlem sürecinde hasta iki kez daha hastaneye yatırılmıştır: Mart sonunda şiddetli kabızlık ve bulantı-kusma nedeniyle genel cerrahi yatışı; Temmuz sonunda sternal insizyon bölgesinde dikiş ayrılması (dehissens) ve ağır yara enfeksiyonu nedeniyle kardiyovasküler cerrahi yatışı. Nisan ayında evde üç kez şiddetli hipertansif atak (en yükseği 168/103 mmHg) yaşanmış, sublingual kaptopril ile kontrol altına alınmıştır.

Rapor tarihi itibarıyla hasta ayaktan izlemde; 10 Eylül kontrol INR değeri (2,12) mekanik kapak için hedeflenen terapötik aralıkta (2,0–3,0), son 7 günlük tansiyon ortalaması (111/75 mmHg) hedeftedir. 4 Eylül’de başlanan Klamoks kürü 10 Eylül’de başarıyla tamamlanmış, derinleşen mikrositik anemiye (Hb 9,7 g/dL, ferritin 19 µg/L, demir 15 µg/dL) yönelik Ferro Sanol Duodenal 100 mg başlanmıştır. Hafif düzeyde süregelen enflamasyon (CRP 11,3 mg/L) gerileme trendindedir. Lipid profilinde de kötüleşme (yüksek LDL/kolesterol, düşük HDL) izlenmektedir. Bu bulguların her biri Bölüm 8’de literatürle karşılaştırılmış, Bölüm 9’da ise hekimle görüşülmesi önerilen somut maddeler halinde özetlenmiştir.

2. Klinik Zaman Çizelgesi

Acil başvurudan güncel duruma kadar tüm kayıtlı klinik olaylar, kronolojik sırayla:

19 Şubat 2026, 17:21 • Defne Devlet Hastanesi [Acil Başvuru]

Hasta ani başlayan yırtıcı karakterde şiddetli göğüs ve sırt ağrısı ile ambulansla acil servise getirildi. İlk müdahale yapıldı, EKG, kardiyak troponin ve biyokimya testleri alındı. Hipertansif kriz ve diseksiyon şüphesiyle acil ileri merkeze sevki sağlandı.

19 Şubat 2026, 18:44 • Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi [Acil Başvuru]

Acil servise giriş yapıldı, hemogram paneli alındı. İntrakraniyal kanama ekartasyonu için acil Diffüzyon MRG (20:17) ve Kontrastsız Beyin BT (20:30) çekildi. Aktif kanama saptanmadı.

19 Şubat 2026, 21:41 • Kırıkhan Devlet Hastanesi [Acil Başvuru]

Kontrastlı Torasik ve Abdominal BT Anjiyografi çekildi. Aort kökünden iliak bifurkasyona dek uzanan Tip A Aort Diseksiyonu ve asendan aort anevrizması (5.3 cm) kesin tanısı kondu. Acil cerrahi için sevk edildi.

19 Şubat 2026, 23:22 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Kardiyovasküler Cerrahi servisine acil yatışı yapıldı. Ameliyat öncesi kapsamlı yoğun bakım hazırlık paneli ve crossmatch kan uyumu testleri tamamlandı.

20 Şubat 2026, 08:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Cerrahi Operasyon]

Derin hipotermik sirkülatuar arrest altında acil Bentall prosedürü uygulandı: 32mm Dacron asendan aort grefti ve 25mm Carbomedics mekanik aort kapak replasmanı yapıldı, koroner butonlar implante edildi.

2 Mart 2026, 09:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Taburcu]

Başarılı ameliyat ve yoğun bakım/servis süreci sonrası şifa ile taburcu edildi. Ömür boyu Warfarin kullanımı için rapor çıkarıldı. Günlük idame ilaçları (Dilatrend, EcopirinPro vs.) başlandı.

30 Mart 2026, 14:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Kabızlık ve bulantı/kusma şikayetleri nedeniyle yatış yapıldı; lavman uygulandı ve enfeksiyon parametreleri takip edildi (CRP: 101.4). Sternal yara enfeksiyonu takibine devam edildi.

31 Mart 2026, 14:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Taburcu]

Lavman sonrası gaz-gaita deşarjı sağlandı ve hasta şifa ile taburcu edildi.

16 Nisan 2026, 10:55 · Evde [Hipertansif Atak]

Kan basıncı 146/93 mmHg olarak ölçülmüş olup evde tansiyon takibi sıklaştırıldı.

17 Nisan 2026, 14:35 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon 156/97 mmHg'ye yükseldi. Acil antihipertansif olarak Kapril (25 mg) dilaltı alındı.

17 Nisan 2026, 23:39 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon 152/102 mmHg'ye yükseldi. Acil antihipertansif olarak Kapril (25 mg) dilaltı alındı.

18 Nisan 2026, 19:35 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon tehlikeli seviyelere (168/103 mmHg) yükseldi; Kapril (25 mg) müdahalesi ile kriz kontrol altına alındı.

23 Temmuz 2026, 11:15 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Sternal insizyon bölgesinde dikişlerin açılması (dehissens), şiddetli enfeksiyon ve doku defekti nedeniyle KVC servisine yatırıldı. Kapsamlı laboratuvar tahlili alındı. Çoklu sütür atıldı, beyaz kan transfüzyonu uygulandı ve yoğun yara bakımı başlatıldı.

28 Temmuz 2026, 11:15 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Taburcu]

Taburcu oldu

3. İlk Başvuru: Dört Hastaneli Sevk Zinciri

Tanının kesinleşmesine kadar geçen ~6 saatlik süreçte hasta üç kez sevk edilmiştir:

Merkez Saat Yapılan İşlemler

1 Defne Devlet 19 Şubat İlk acil başvuru yapıldı. Ambulans Hastanesi 2026, 17:21 ile getirilen hastanın EKG'si çekildi, kardiyak enzimleri (Troponin vb.) ve rutin biyokimyası çalışıldı. Hipertansif kriz tanısıyla ileri merkez sevk başlatıldı.

2 Mustafa Kemal 19 Şubat Nörolojik kanama komplikasyonunu Üniversitesi 2026, 18:44 ekarte etmek için acil Diffüzyon Hastanesi MRG ve Beyin BT çekildi. Kontrastlı madde öncesi güvenliği sağlandı.

3 Kırıkkhan Devlet 19 Şubat Kontrastlı Torakoabdominal BT Hastanesi 2026, 21:41 Anjiyografi tamamlandı. 5.3 cm asendan aort anevrizması ve Tip A aort diseksiyonu kesin tanısı konularak acil cerrahiye sevk kararı alındı.

4 Özel İskenderun 19 Şubat KVC ekibi tarafından ameliyata Gelişim 2026, 23:22 hazırlık için acil yatışı yapıldı. Hastanesi Crossmatch ve pre-op testleri

tamamlanıp sabah erken saatte acil açık kalp ameliyatından çıktı.

Klinik not: Başvuruda sağ kol tansiyonunun sol kola göre 40 mmHg düşük ölçülmesi (kol-arası TA farkı), Tip A aort diseksiyonunda malperfüzyon/dal tutulumu açısından önemli bir fizik muayene bulgusudur ve literatürde tanısal şüpheyi güçlendiren klasik işaretlerden biridir.

4. Cerrahi Müdahale: Bentall Prosedürü

20 Şubat 2026, saat 08:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi · Doç. Dr. Emre KUBAT (Kalp ve Damar Cerrahisi)

Yapılan Anatomi / Cerrahi Değişiklikler

- Dilate nativ asendan aort rezeke edildi (5.3 cm anevrizma); 32mm polyester Dacron vasküler greft ile replase edildi (değiştirildi).
- Yetersiz nativ aort kapağı, 25mm Carbomedics çift yapraklı metalik mekanik protez kalp kapağı ile replase edildi.
- Koroner arter butonları vasküler grefte implante edildi (Bentall Prosedürü 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlandı).
- Selektif antegrad serebral perfüzyon amacıyla sağ brakiyal arter ve sağ common karotid artere (CCA) cerrahi kanülasyon uygulandı; ardından primer vasküler onarım sağlandı.

Operasyon Notu (Epikriz Özeti)

Genel anestezi altında supin pozisyonundaki hastaya sağ brakiyal arter ve sağ ortak karotis arter (CCA) kanülasyonu uygulanmış; median sternotomi ile perikard açılmış, hemorajik mayi aspire edilmiştir. Belirgin dilate olan ve koaptasyonu bozulmuş aort kökü rezeke edilmiş; 32 mm Dacron greft, distalde hemiarkusu da içerecek şekilde anastomoz edilmiştir. Koroner butonlar hazırlanarak 25 mm Carbomedics metalik kapak-greft kompozitine implante edilmiş, dekanüle edilen brakiyal arter ve sağ CCA primer onarılmıştır.

Sonuç: Ameliyat komplikasyonsuz tamamlanmış, hasta 2 Mart 2026'da (ameliyattan 10 gün sonra) şifa ile taburcu edilmiş; ömür boyu warfarin kullanımı için rapor düzenlenmiştir.

3. Postoperatif Seyir ve Komplikasyonlar

Ameliyat sonrası 6,6 aylık dönemde kayıtlı üç ana komplikasyon süreci.

① Gastrointestinal Komplikasyon (30–31 Mart 2026)

Ameliyattan 40 gün sonra, 5 gündür defekasyon yapamama ve bulantı/kusma şikâyetiyle Genel Cerrahi servisine yatırılmıştır. Karın muayenesi rahat, defans/rebound negatif olarak değerlendirilmiş; lavman uygulaması sonrası gaz-gaita deşarjı sağlanarak ertesi gün şifa ile taburcu edilmiştir. Bu dönemde CRP 101,4 mg/L'ye kadar yükselmiş; aynı hafta (16 Mart) INR değeri 8,46'ya kadar yükselerek supratrapötik düzeye ulaşmış, warfarin dozunun düşürülmesiyle yönetilmiştir.

② Evde Hipertansif Ataklar (16–18 Nisan 2026)

Üç gün içinde art arda üç kez şiddetli kan basıncı yükselmesi kaydedilmiştir (146/93 → 156/97 → 152/102 → 168/103 mmHg). Her atakta sublingual Kapril (kaptopril 25 mg) ile akut kontrol sağlanmıştır. Kısa süre sonra (17 Nisan) BelocZOK kesilerek Dilatrend'e (karvedilol) geçilmiştir.

③ Sternal Yara Dehissensi ve Enfeksiyonu (23–28 Temmuz 2026)

Ameliyattan yaklaşık 5 ay sonra, sternal insizyon bölgesinde dikişlerin ayrılması (dehissens), doku defekti ve şiddetli enfeksiyon bulgularıyla KVC servisine tekrar yatırılmıştır. Çoklu sütür uygulanmış, yoğun yara bakımı başlatılmış; hemoglobinin 7,7 g/dL'ye gerilemesi nedeniyle kan/kan ürünü transfüzyonu uygulanmıştır. Beş günlük yatış sonrası şifa ile taburcu edilmiş; taburculuk sonrası Augmentin+Cipro ile oral antibiyoterapi 4 Ağustos'ta tamamlanmıştır.

Güncel gelişme: 4 Eylül 2026'da, CRP yüksekliği şüphesiyle yeniden ampirik antibiyotik (Klamoks 1000mg, günde 2×1) başlanmış olup 7 günlük kür 10 Eylül'de başarıyla tamamlanmıştır (kesildi). Mart ayında alınan yara kültüründe

üreme olmadığı kayıtlıdır. Bu, sternal enfeksiyon sürecinin tam sonlanmamış veya nüksetmiş olabileceğine işaret edebilir (bkz. Bölüm 9).

Şiddetli Hipertansif Ölçümler (Sistolik ≥ 150 veya Diyastolik ≥ 100 mmHg)

Tarih / Saat Ölçüm

24 Mart 2026, 19:41 154/98 mmHg

17 Nisan 2026, 14:38 156/97 mmHg

17 Nisan 2026, 23:38 152/102 mmHg

18 Nisan 2026, 19:34 168/103 mmHg

31 Temmuz 2026, 21:18 149/101 mmHg

7 aylık dönemde toplam 490 tansiyon ölçümünden yalnızca 5 tanesi bu eşiği aşmıştır — genel olarak iyi kontrollü bir seyir olduğunu göstermektedir.

4. Güncel İlaç Tedavisi

10 Eylül 2026 itibarıyla aktif olan 6 düzenli tedavi ve 1 adet gerektiğinde kullanılan (PRN) ilaç:

İlaç Sınıf Doz Kullanım Not

Panto Mide Koruyucu 40mg günde Düzenli Taburculuk sonrası 1×1 devam edildi (Ferro Sanol'den 1 saat sonra alınmalı)

Dilatrend Beta Blokör 6.25mg Düzenli Taburculuk sonrası günde 2×1 yeni doz ile devam edildi (Yükseltildi)

EcopirinPro Antiplatelet 81mg günde Düzenli Taburculuk sonrası 1×1 devam edildi

Coversyl Antihipertansif 5mg günde Düzenli Doktor tarafından 1×1 başlandı (ACE inhibitörü, kan basıncı regülasyonu)

Warfmadin Antikoagülan 5mg Düzenli Doktor tarafından doz haftalık ayarlaması (INR takibine göre)

Ferro Sanol Demir Preparatı 100mg Düzenli 10 Eylül'de reçetelenip Duodenal (Fe²⁺) günde 1×1 11 Eylül 06:00'da başlandı (sabah aç, Panto'dan 1 saat önce)

Klamoks Antibiyotik 1000mg Tamamlandı 10 Eylül 20:59'da günde 2×1 7 günlük ampirik kür tamamlandı (Kesildi)

Kapril Antihipertansif 25mg PRN / Acil durum tansiyon Gerektiğinde yüksekliği (168/103 mmHg) _____

Antikoagülasyon + antiplatelet birlikte kullanımı: Hasta hem yaşam boyu warfarin (mekanik kapak nedeniyle) hem de düşük doz aspirin (EcopirinPro 81mg) kullanmaktadır. Koroner butonların cerrahi olarak greft üzerine implante edilmiş olması bu kombinasyon için klinik gerekçe oluşturabilir; ancak kanama riskini artırdığından dikkatli izlem önemlidir.

Tüm İlaç Değişiklik Geçmişi (20 farklı ilaç, 66 kayıt)

İlaç Sınıf Tarih İşlem Gerekçe

Tavanic Antibiyotik 8 Mart Ended Tedavi süresi tamamlandı 2026, 09:11 (7 günlük kür)

Cordarone Antiaritmik 12 Mart Ended Doktor tarafından 2026, 12:36 sonlandırıldı (Ritim stabil)

GeralginePlus Analjezik 29 Mart Ended Doktor tarafından 2026, 21:46 sonlandırıldı (Ağrı kontrolü tamamlandı)

Mikostatin Antifungal 29 Mart Ended Doktor tarafından 2026, 23:01 sonlandırıldı (Tedavi süresi tamamlandı)

Levopront Antitussif 30 Mart Ended Doktor tarafından 2026, 09:01 sonlandırıldı (Öksürük kesildi)

Stafine Antibiyotik 5 Nisan Ended Tedavi süresi tamamlandı 2026, 22:46 (7 günlük kür)

BelocZOK Beta Blokör 17 Nisan Ended Doktor tarafından 2026, 08:35 sonlandırıldı (Dilatrend'e geçildi)

Kapril Antihipertansif 18 Nisan Taken Acil durum tansiyon 2026, 19:35 yüksekliği (168/103 mmHg)

Apikobal Vitamin 4 Mayıs Ended Doktor tarafından 2026, 13:31 sonlandırıldı (B12 seviyesi normale döndü)

Coraspin Antiplatelet 27 Temmuz Ended Taburculuk öncesi 2026, 23:59 EcopirinPro'ya dönüş yapıldı

Sulcid Antibiyotik 28 Temmuz Ended Taburculuk sonrası oral 2026, 12:00 antibiyotik tedavisine (Augmentin + Cipro) geçildi

Panto Mide Koruyucu 28 Temmuz Resumed Taburculuk sonrası devam 2026, 13:59 edildi

Dilatrend Beta Blokör 28 Temmuz Resumed Taburculuk sonrası yeni 2026, 13:59 doz ile devam edildi (Yükseltildi)

EcopirinPro Antiplatelet 28 Temmuz Resumed Taburculuk sonrası devam 2026, 13:59 edildi

Oksapar Antikoagülan 3 Ağustos Ended Warfmadin'e geçildi. 2026, 20:59

Coversyl Antihipertansif 4 Ağustos Started Doktor tarafından başlandı 2026, 07:00 (ACE inhibitörü, kan basıncı regülasyonu)

Cipro Antibiyotik 4 Ağustos Ended Tedavi süresi tamamlandı 2026, 09:45 (7 günlük kür)

Augmentin Antibiyotik 4 Ağustos Ended Tedavi süresi tamamlandı 2026, 09:45 (7 günlük kür)

Warfmadin Antikoagülan 18 Ağustos Changed Doktor tarafından doz 2026, 12:00 ayarlaması (INR takibine göre)

Klamoks Antibiyotik 10 Eylül Ended 7 günlük kür sonu 2026, 20:59

Ferro Sanol Demir Preparatı 11 Eylül Started Demir eksikliği anemisi Duodenal 2026, 06:00 tedavisi (100 mg Fe²⁺, 1×1 aç)

5. Vital Bulgu Trendleri

Ev takibinde kayıtlı 490 tansiyon ve 175 kilo ölçümünün aylık özetleri.

Kan Basıncı — Aylık Özet (mmHg)

Ay Ölçüm Ortalama Min Maks

Mart 2026 69 109.2/76.8 83/60 154/98

Nisan 2026 96 109.4/77.8 85/60 168/103

Mayıs 2026 63 118.6/80.2 100/68 140/95

Haziran 2026 68 127.2/84.6 109/72 149/99

Temmuz 2026 84 124.9/83.2 102/60 149/101

Ağustos 2026 89 118.7/79.9 99/65 139/95

Eylül 2026 21 111/76 101/68 122/82

Mart–Nisan aylarında ortalama sistolik ~109 mmHg iken, Haziran–Temmuz'da ortalama 125–127 mmHg'ye yükselmiş; Ağustos'ta Coversyl eklenmesinin ardından Eylül ayı ortalaması tekrar 111 mmHg'ye gerilemiştir. Genel eğilim olumludur ancak hedefin (<120 mmHg) zaman zaman üzerine çıkmaktadır.

Kilo — Aylık Özet

Ay Ölçüm Ortalama Aralık

Mart 2026 25 81.2 kg 78.9 – 85.3 kg

Nisan 2026 30 76.3 kg 74.8 – 78.6 kg

Mayıs 2026 31 78.1 kg 75.8 – 80.2 kg

Haziran 2026 27 79.3 kg 78.4 – 80.7 kg

Temmuz 2026 26 78.4 kg 77.5 – 79.4 kg

Ağustos 2026 27 78.7 kg 77.9 – 80 kg

Eylül 2026 10 78.8 kg 78.4 – 79.4 kg

Ameliyat sonrası ilk haftalarda gözlenen kilo kaybı (85,3 → ~75 kg aralığı) sonrasında kilo Mayıs ayından itibaren 78–79 kg civarında stabilize olmuştur.

6. Laboratuvar Bulguları ve Trendler

19 Şubat – 10 Eylül 2026 arası, 92 test panelinde toplam 2.032 ayrı laboratuvar ölçümünden derlenen, klinik açıdan öncelikli parametrelerin özeti.

Koagülasyon (Antikoagülasyon Takibi)

Mekanik kalp kapağı nedeniyle ömür boyu izlenir. PT/aPTT warfarin nedeniyle beklenen şekilde uzamıştır; tek başına anormal sayılmaz. D-Dimer yalnızca tanısında bir kez ölçülmüştür.

Parametre Referans İlk Son Min–Maks n Durum Ölçüm** Ölçüm**

INR (INR) 2,0–3,0 (tedavi 1.1 (19 2.12 (10 1.1–8.46 39 TEDAVİ hedefi) INR Şubat Eylül ARALIĞINDA 2026) 2026)

Protrombin 9.6000–12.0000 sn 13.1 (19 19.8 (10 11.9–64 39 ANTİKOAG. Zamanı (PT) Şubat Eylül İLE TAKİP (PT) 2026) 2026)

aPTT (APTT) 23.9000–33.2000 27.9 (19 44.8 (10 27.9–85.5 27 ANTİKOAG. sn Şubat Eylül İLE TAKİP 2026) 2026)

D-Dimer 0.0000–500.0000 5510 (19 9656.4 (19 5510–9656.4 2 YÜKSEK (Kantitatif) ng/mL Şubat Şubat

(D-DIMER) 2026) 2026)

Enflamasyon Belirteçleri

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm Ölçüm****

C-Reaktif 0.0000–5.0000 2.6 (19 11.3 (8 2.6–154 23 YÜKSEK Protein (CRP) mg/L
Şubat Eylül
(CRP) 2026) 2026)

Sedimentasyon 0.0000–20.0000 61 (30 46 (5 46–61 2 YÜKSEK (ESR) (SEDIM)
mm/saat Mart 2026) Mayıs
2026)

Nötrofil / — - 1.47 (15 1.36 (8 1–1.47 8 NORMAL Lenfosit Oranı Haziran Eylül
(NLR) (NLR) 2026) 2026)

Hematoloji ve Anemi Paneli

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm Ölçüm****

Hemoglobin 13.5000–17.5000 14 (19 9.7 (8 7.7–14 31 DÜŞÜK (HGB) (HGB) g/dL
Şubat Eylül
2026) 2026)

Hematokrit 40.0000–52.0000 % 41.4 (19 29.7 (8 25–41.4 32 DÜŞÜK (HCT) (HCT)
Şubat Eylül
2026) 2026)

Eritrosit 4.2000–6.2000 4.63 (19 3.89 (8 2.73–4.63 31 DÜŞÜK Sayısı (RBC) 10¹²/L
Şubat Eylül
(RBC) 2026) 2026)

Trombosit 150.0000–403.0000 163 (19 365 (8 88–489 31 NORMAL Sayısı (PLT)
10⁹/L Şubat Eylül
(PLT) 2026) 2026)

Lökosit Sayısı 4.5000–11.0000 10.62 (19 7.97 (8 7.85–27.1 32 NORMAL (WBC) (WBC)
10⁹/L Şubat Eylül
2026) 2026)

MCH (MCH) 27.0000–34.0000 pg 30.8 (19 24.9 (8 24.5–30.8 24 DÜŞÜK Şubat Eylül
2026) 2026)

MCV (MCV) 80.0000–100.0000 fL 88 (19 76.4 (8 76.4–92.3 24 DÜŞÜK Şubat Eylül
2026) 2026)

MCHC (MCHC) 32.0000–36.0000 35.1 (19 32.7 (8 30.1–35.1 24 NORMAL g/dL Şubat
Eylül
2026) 2026)

Eritrosit 10.0000–16.5000 % 13.9 (19 17.8 (8 13.9–20.2 23 YÜKSEK Dağılım Şubat
Eylül
Genişliği 2026) 2026)
(RDW-CV)
(RDW-CV)

Eritrosit 37.0000–49.0000 fL 45.7 (19 50.8 (8 45.7–61.2 23 YÜKSEK Dağılım Şubat
Eylül
Genişliği 2026) 2026)
(RDW-SD)
(RDW-SD)

Ferritin 30.0000–400.0000 19 (8 19 (8 19–19 1 DÜŞÜK (FERRITIN) µg/L Eylül Eylül
2026) 2026)

Demir (IRON) 59.0000–158.0000 15 (8 15 (8 15–15 1 DÜŞÜK µg/dL Eylül Eylül
2026) 2026)

UIBC (UIBC) 110.0000–370.0000 326.8 (8 326.8 (8 326.8–326.8 1 NORMAL µg/dL
Eylül Eylül
2026) 2026)

Vitamin B12 211.0000–946.0000 638 (8 638 (8 638–638 1 NORMAL (B12) pg/mL
Eylül Eylül
2026) 2026)

Folat (FOLATE) 3.1000–17.5000 4.76 (8 4.76 (8 4.76–4.76 1 NORMAL ng/mL Eylül
Eylül
2026) 2026) —————

Böbrek Fonksiyonu ve Elektrolitler

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm** Ölçüm**

Kreatinin 0.6000–1.3000 mg/dL 1.11 (19 1.02 (8 0.76–1.13 25 NORMAL (CREA)
Şubat Eylül
2026) 2026)

Üre Azotu (BUN) 7.0000–28.0000 18.3 (19 11 (8 9.2–29 25 NORMAL (BUN) mg/dL
Şubat Eylül
2026) 2026)

t GFH (CKD-EPI — mL/dk/1.73 m² 72.58 (20 75.58 (25 72.58–94 7 NORMAL formülü
ile) Mart 2026) Ağustos
(GFR_CKD_EPI) 2026)

Sodyum (NA) 135.0000–145.0000 136 (19 137 (8 131–149 21 NORMAL mmol/L
Şubat Eylül
2026) 2026)

Potasyum (K) 3.5000–5.5000 3.64 (19 4.65 (8 3.44–4.88 21 NORMAL mmol/L Şubat
Eylül
2026) 2026)

Klor (CL) 98.0000–107.0000 103 (19 103 (8 94–104 10 NORMAL mmol/L Şubat Eylül
2026) 2026)

Kalsiyum (CA) 8.8000–10.2000 8.66 (19 9.09 (25 8.2–9.44 5 NORMAL mg/dL Şubat
Ağustos
2026) 2026)

Fosfor (PHOS) 2.3000–3.7000 mg/dL 2.89 (8 2.89 (8 2.89–2.89 1 NORMAL Eylül
Eylül
2026) 2026)

Magnezyum (MG) 1.5800–2.5500 mg/dL 1.81 (19 2.02 (8 1.81–2.02 4 NORMAL Şubat
Eylül
2026) 2026)

Albümin (ALB) 35.0000–52.0000 g/L 40 (19 43 (25 33–43 6 NORMAL Şubat Ağustos
2026) 2026)

Lipid Profili ve Glukoz Metabolizması

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm** Ölçüm**

Kolesterol 140.0000–200.0000 179 (19 210 (8 179–210 2 YÜKSEK (CHOL) mg/dL
Şubat Eylül
2026) 2026)

LDL Kolesterol 60.0000–130.0000 119.6 (19 141 (8 119.6–141 2 YÜKSEK (Direkt)
(LDL) mg/dL Şubat Eylül
2026) 2026)

HDL Kolesterol 35.0000–75.0000 35.4 (19 34 (8 34–35.4 2 DÜŞÜK (HDL) mg/dL
Şubat Eylül
2026) 2026)

Trigliserid 55.0000–200.0000 123 (19 164 (8 123–164 2 NORMAL (TRIG) mg/dL
Şubat Eylül
2026) 2026)

Glukoz (GLU) 80.0000–110.0000 81 (19 102 (8 81–146 21 NORMAL mg/dL Şubat
Eylül
2026) 2026)

HbA1c (%) 4.8000–5.9000 % 5.3 (8 5.3 (8 5.3–5.3 1 NORMAL (HBA1C) Eylül Eylül
2026) 2026)

Tiroid Fonksiyonu

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm** Ölçüm**

TSH (TSH) 0.2700–4.2000 0.86 (19 0.279 (8 0.279–0.86 2 NORMAL mIU/L Şubat
Eylül
2026) 2026)

Serbest T3 2.0000–4.4000 2.99 (19 2.58 (8 2.58–2.99 2 NORMAL (FT3) ng/L Şubat
Eylül
2026) 2026)

Serbest T4 0.9300–1.7000 1.51 (19 1.45 (8 1.45–1.51 2 NORMAL (FT4) ng/dL Şubat
Eylül
2026) 2026) —————

Karaciğer Fonksiyon Testleri

Parametre Referans İlk Son Min–Maks n Durum Ölçüm Ölçüm****

Alanin 5.0000–50.0000 U/L 19 (19 14 (25 7–62 21 NORMAL Aminotransferaz Şubat
Ağustos
(ALT) (ALT) 2026) 2026)

Aspartat 5.0000–46.0000 U/L 19 (19 14 (25 13–84 21 NORMAL Aminotransferaz
Şubat Ağustos
(AST) (AST) 2026) 2026)

Alkalen Fosfataz 40.0000–129.0000 56 (19 86 (25 56–95 4 NORMAL (ALP) U/L Şubat
Ağustos
2026) 2026)

Gamma Glutamil 7.0000–60.0000 U/L 15 (19 15 (8 15–41 3 NORMAL Transferaz
(GGT) Şubat Eylül
(GGT) 2026) 2026)

Total Bilirubin 0.0000–1.0000 mg/dL 0.75 (19 0.6 (25 0.6–1.35 11 NORMAL (TBIL)
Şubat Ağustos
2026) 2026)

Direkt Bilirubin 0.0000–0.3000 mg/dL 0.23 (19 0.24 (8 0.17–0.32 15 NORMAL (DBIL)
Şubat Eylül
2026) 2026)

Laktat 135.0000–225.0000 226 (19 176 (8 176–281 5 NORMAL Dehidrogenaz U/L
Şubat Eylül
(LDH) (LDH) 2026) 2026)

Kardiyak Enzim

Postoperatif miyokard hasarı ekartasyonu için.

Parametre Referans İlk Son Min-Maks n Durum Ölçüm Ölçüm****

Troponin I 0.0000–45.0000 17.76 (19 10 (20 10–17.76 2 NORMAL (TROP-I) ng/L
Şubat Mart 2026)
2026)

Dikkat çeken örüntü — mikrositer anemi: Hemoglobin (9,7 g/dL), hematokrit (%29,7), ferritin (19 µg/L) ve serum demiri (15 µg/dL) referans altında; MCV zaman içinde 88'den 76,4 fL'ye gerilemiş, RDW-CV %13,9'dan %17,8'e yükselmiştir. Bu örüntü demir eksikliği anemisi ile uyumludur (bkz. Bölüm 9).

9. Görüntüleme Bulguları — Kronolojik Özet

Tarih Tetkik Ana Bulgular Sonuç

19 Şub 2026 Diffüzyon MRG Akut infarkt/iskemi lehine Normal (Beyin) kısıtlama yok.

19 Şub 2026 Acil Beyin BT Kalvaryal fraktür veya Normal kanama yok.

19 Şub 2026 Abdominal BT Asendan aorta 5,3 cm; Tip A Anjiyografi diseksiyon flebi aort diseksiyon — kökünden iliak batın içi bifurkasyona dek. uzanım

19 Şub 2026 Torasik Aorta BT Asendan aorta 5,3 cm; Tip A Aort Anjiyografi diseksiyon flebi aort Diseksiyonu kökünden iliak — tanı bifurkasyona dek. kesinleşti

20 Mar 2026 Akciğer Grafisi Postoperatif Beklenen kardiyomegali; aktif postop görünüm plevral efüzyon yok.

5 May 2026 Kontrol Abdominal Abdominal aorta suprarenal Stabil BT Anjiyografi 38mm; diseksiyon flebi ektazi + devam; safra taşı; insidental bilateral böbrek kisti. bulgular

5 May 2026 Kontrol Toraks BT Aort kökü 46mm, ark 46mm, Operasyon loju Anjiyografi inen aorta 39mm; stabil perikardiyal efüzyon yok.

17 Tem 2026 Acil Toraks BT Sternumda defekt; minimal Akut şikayete (Kontrastsız) perikardiyal efüzyon; yönelik — fibrotik değişiklikler. aort çapları ölçülmedi —

Aort Çapı Seyri (mm)

Tarih Aort Arkus İnen Abdominal Kökü** Aorta** (suprarenal)****

19 Şub 2026 (tanı — — 5,3 cm — anı) (asendan)

5 May 2026 46 mm 46 mm 39 mm 38 mm (~10,6 hafta postop) —

Takip görüntüleme aralığı: Ameliyattan bu yana geçen süre ~6,6 ay olup, ilk kontrol BT anjiyografisi ameliyattan ~10,6 hafta sonra (5 Mayıs) yapılmıştır. Bu tarihten itibaren 4 ay içinde planlı bir kontrol aort BT anjiyografisi kaydına rastlanmamıştır; 17 Temmuz'daki tetkik kontrastsız olup aort çaplarını yeniden ölçmemiştir.

Kan Basıncı Sınıflandırması (ESC 2023 Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu): Aort cerrahisi ve rezidüel diseksiyon hastalarında hedef kan basıncı <120/80 mmHg olarak önerilmekte; sistolik kan basıncındaki dP/dt kesme stresinin kontrol altına alınması esastır [Mancia et al., 2023].

Mekanik Kapak Sonrası Antikoagülasyon (2021 ESC/EACTS Valvüler Kalp Hastalığı Kılavuzu): Mekanik protez aort kapağı taşıyan hastalarda ömür boyu vitamin K antagonisti (Warfarin) ile INR 2.0-3.0 aralığında antikoagülasyon sınıf I endikasyondur [Vahanian et al., 2021].

7. Bilimsel Literatür ile Karşılaştırma

Aşağıda hastanın klinik seyrine ilişkin yedi ana başlık, güncel tıbbi literatür ve kılavuzlarla (kaynak numaraları Bölüm 12'de) karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir.

① Bentall Prosedürü Sonrası Sağkalım [Kaynak 1, 5, 9]

Güncel seriler, aort köküne sınırlı hastalıkta Bentall prosedürünün operatif mortalitesinin malperfüzyon olmayan hastalarda ~%5,7, malperfüzyon eşlik eden olgularda ~%21,5'e kadar çıkabildiğini göstermektedir. Geniş bir seride (1997–2023, 1.493 hasta) operasyonu atlatan hastaların uzun dönemli sağkalımının genel Bentall popülasyonuna benzer seyrettiği bildirilmiştir. Bu hastada ameliyat komplikasyonsuz tamamlanmış ve 10 gün içinde şifa ile taburcu edilmiştir — literatürdeki başarılı vaka seyriyle uyumludur.

② Mekanik Aort Kapağında Hedef INR Aralığı [Kaynak 2]

2020 ACC/AHA Kapak Hastalığı Kılavuzu, ek risk faktörü taşımayan bileaflet mekanik aort kapağı hastalarında INR hedefini 2,5 (pratikte ~2,0–3,0) olarak önermektedir; ek risk faktörü varlığında hedef 3,0'a çıkar. Hastanın son INR değeri (2,12) bu aralıktadır. Ancak 16 Mart'ta INR'nin 8,46'ya kadar yükseldiği, kanama açısından yüksek riskli bir supratrapötik dönem yaşanmıştır.

③ Warfarin + Aspirin Birlikte Kullanımı [Kaynak 2, 10]

Mekanik kapak hastalarında, ek bir endikasyon olmadıkça rutin aspirin eklenmesi sınırlı bir endikasyondur; kombinasyon tromboembolik olayları azaltmakla birlikte kanama riskini artırır. Bu hastada koroner butonların cerrahi olarak greft üzerine reimplante edilmiş olması aspirin eklenmesi için makul bir gerekçe oluşturabilir; EcopirinPro + Warfarin kombinasyonu kılavuzlarla uyumlu görünse de yakın izlem gerektirir.

④ Derin Sternal Yara Enfeksiyonu / Dehissens [Kaynak 3, 4]

Kardiyak cerrahi sonrası derin sternal yara enfeksiyonu sıklığı %0,5–3, dehissens sıklığı %0,4–5 aralığında bildirilmektedir. Risk faktörleri arasında diyabet, obezite, KOAH, uzamış baypas süresi, reoperasyon ve transfüzyon sayılır. Bu hastada 23 Temmuz'da gelişen dehissens+enfeksiyon başarıyla yönetilmiş, ancak 4 Eylül'de CRP yüksekliği nedeniyle yeniden antibiyoterapi başlanması sürecin tam sonlanmamış olabileceğine işaret edebilir.

⑤ Aort Diseksiyonu Sonrası Kan Basıncı Hedefi [Kaynak 6, 7]

Aort diseksiyonu onarımı sonrası sistolik kan basıncını 120 mmHg altında tutmanın geç reoperasyon riskini belirgin azalttığı gösterilmiştir (SBP<120 grubunda 10–15 yıllık reoperasyonsuz sağkalım %92, SBP>140 grubunda %30–49). Hastanın dönemsel ortalama tansiyonu 111–127/75–85 mmHg aralığında olup, Haziran–Temmuz'da hedefin üzerinde seyretmiş, Ağustos'ta Coversyl eklenmesiyle Eylül'de tekrar hedefe yaklaşmıştır.

⑥ Kardiyak Cerrahi Sonrası Anemi ve Demir Eksikliği [Kaynak 8, 11]

Kardiyak cerrahi sonrası hastaların büyük çoğunluğunda en az hafif anemi görülür; genellikle mutlak veya fonksiyonel demir eksikliğiyle ilişkilidir. Ferritin <100 µg/L demir eksikliği için tanı ölçütüdür; güncel yaklaşım önce oral, yetersiz yanıtta intravenöz demir önerir. Bu hastada ferritin 19 µg/L, demir 15 µg/dL ile belirgin düşük olup MCV/RDW değişimi demir eksikliği anemisini desteklemektedir.

⑦ Ameliyat Sonrası Görüntüleme Takip Sıklığı [Kaynak 6]

AHA'nın kronik aort diseksiyonu görüntüleme takibi bilimsel açıklaması, cerrahi onarım sonrası 6. ve 12. ayda, sonrasında yıllık kontrol görüntülemesini önermektedir. Bu hastada ilk kontrol BT anjiyografisi ameliyattan ~10,6 hafta sonra yapılmış, sonraki ~4 ayda planlı bir aort BT anjiyografisi kaydına rastlanmamıştır; ~6,6 aylık süre dikkate alındığında 6-aylık kontrol görüntüleme zamanı gelmiştir.

8. Hekiminizle Görüşülmesi Önerilen Noktalar

Bu bölüm bir tanı veya tedavi talimatı değildir; yalnızca mevcut verilerden ortaya çıkan ve bir sonraki hekim kontrolünde gündeme getirilmesi faydalı olabilecek gözlemlerin özetidir.

1. Kronik demir eksikliği anemisi | Hemoglobin (9,7 g/dL), ferritin (19 µg/L) ve serum demiri (15 µg/dL) düşük; MCV gerilemiş, RDW yükselmiştir. Demir replasman tedavisi | ihtiyacının ve — warfarin+aspirin kullanımı göz önüne alınarak — olası gizli gastrointestinal kan kaybının araştırılıp | araştırılmayacağının hekimle görüşülmesi önerilir. |

2. Süregelen hafif enflamasyon ve yeni antibiyotik kürü | CRP referans

üstü seyretmeye devam etmiş, 4 Eylül'de yeniden | yükselmesi üzerine ampirik antibiyotik başlanmıştır. 10 Eylül'de | kür tamamlandığında CRP'nin tekrar kontrolü ve gerekirse enfeksiyon kaynağının netleştirilmesi önerilir. |

3. Lipid profilinde kötüleşme | | Kolesterol (210 mg/dL) ve LDL (141 mg/dL) referans üstü, HDL (34 | mg/dL) referans altıdır. Statin tedavisi ihtiyacının | değerlendirilmesi hekimle görüşülebilir. |

4. Aralıklı kan basıncı yükselmeleri | | Dönemsel ortalamalar zaman zaman <120 mmHg hedefinin üzerine | çıkmaktadır. Ağustos'ta eklenen Coversyl sonrası olumlu iyileşme | izlenmekle birlikte, sürdürülebilirliğinin düzenli kontrollerde | değerlendirilmesi önerilir. |

5. 6 aylık kontrol aort BT anjiyografisi | | Son kapsamlı kontrastlı aort görüntülemesi ~4,2 ay önce | yapılmıştır. KVC/kardiyoloji ile 6-aylık kontrol BT anjiyografisinin planlanması için temasa geçilmesi önerilir. |

6. Kanama bulgularına karşı farkındalık | | Warfarin + aspirin birlikte kullanımı ve geçmişteki supratherapötik | INR atağı (8,46) göz önüne alındığında, dış eti kanaması, kolay | morarma, siyah/katran renkli dışkı gibi bulguların hekime | bildirilmesi önemlidir. |

7. Tiroid fonksiyonunun izlenmesi | | TSH değeri referans aralığının alt sınırına yaklaşmıştır (0,279). | Ağır cerrahi/hastalık sonrası geçici olabilecek bu değerlerin bir | sonraki kontrolde tekrar değerlendirilmesi makul olacaktır. |

9. Kaynakça (APA 7th Edition)

[1] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, ve ark. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227.

[2] 2020 ACC/AHA Heart Valve Disease Guideline: Key Perspectives (Part 3). American College of Cardiology, acc.org.

- [3] Ampatzidou F, Sileli M, Madesis A, ve ark. Predisposing factors for deep sternal wound infection after cardiac surgery. Crit Care. 2015;19(Suppl 1):P10.
- [4] Kaul P. Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. J Cardiothorac Surg. 2017;12:94.
- [5] Lau C, Gregg A, Ram E, ve ark. Long-term survival and operative outcomes of the Bentall procedure. J Thorac Cardiovasc Surg. 2025 (Weill Cornell Medicine, n=1.493).
- [6] Fleischmann D, Afifi RO, Casanegra AI, ve ark. Imaging and Surveillance of Chronic Aortic Dissection: A Scientific Statement from the AHA. Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15(3):e000075.
- [7] Melby SJ ve ark. (Washington University in St. Louis) — Aort diseksiyonu onarımı sonrası kan basıncı kontrolü ve geç reoperasyon riski ilişkisi.
- [8] Venturini E, Iannuzzo G, Di Lorenzo A, ve ark. Short-term treatment of iron deficiency anemia after cardiac surgery. Int J Cardiol Heart Vasc. 2022;40:101038.
- [9] Surgery for acute type A aortic dissection (derleme); Pittsburgh serisi ve IRAD verileri.
- [10] Should patients on long-term warfarin take aspirin for heart disease? Cleve Clin J Med. 2008;75(3):206–208.
- [11] Anemia and Iron Deficiency in Cardiac Surgery Patients: Prevalence, Implications, and Therapeutic Considerations (derleme, PMC).

10. Önemli Bilgilendirme ve Sorumluluk Reddi

Bu rapor, Klinik Takip uygulamasından dışa aktarılan hasta verilerinin klinik karar destek sistemi tarafından derlenmesi ve ilgili bilimsel literatürle karşılaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bir tıbbi tanı, tedavi planı veya reçete niteliği taşımaz; hekim muayenesinin ve klinik değerlendirmesinin yerini tutmaz. Rapordaki tüm bulgular ve öneriler, hastanın tedavisini yürüten hekimlerle birlikte değerlendirilmelidir. Literatür karşılaştırmaları genel popülasyon çalışmalarına dayanmaktadır ve bireysel hastaya doğrudan uygulanabilirliği hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Rapor oluşturulma tarihi: 09.09.2026 · Kaynak veri: Klinik Takip uygulaması tam veri dışa aktarımı · Klinik Karar Destek Konsültasyonu

Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., ... & Wojakowski, W. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561-632.

Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., ... & Kjeldsen, S. E. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874-2071.

Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.

Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024). EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.